Disciplina: PEDIATRIA

Área do conhecimento:

Hepatites virais

Prof. PATRICIA DAHAN

SUPREMA

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora

PLANO DE ENSINO

Curso: Medicina

Data: 2º Semestre de 2023 **Período:** 8º

Professor: PATRICIA DAHAN

Conteúdo Programático Abordado nesta aula:

Hepatites virais

SUPREMA

Hepatites virais

Objetivos da aula

- Conhecer as principais hepatites virais, sua forma de transmissão, diagnóstico e prevenção em pediatria

SUPREMA

HEPATITE A

- Muitos casos sem registros (assintomáticos)
- Problema de saúde pública no mundo inteiro
- Doença infecciosa notificável comum

SUPREMA

HEPATITE A

- Associada a condições sanitárias e de higiene precárias

- Importante causa de morbidade e eventual mortalidade
- Não cronifica

- Crianças geralmente assintomáticas
- Adultos frequentemente sintomáticos

SUPREMA

HEPATITE A

TRANSMISSÃO FECAL ORAL
(pessoa a pessoa ou água/ alimentos contaminados/ raramente sangue e sexual)

VIREMIA
Início dos sintomas até final da icterícia

GRUPOS DE RISCO
Pessoas que vivem ou viajam para países endêmicos, pessoas que convivem com infectados, contatos sexuais, drogaditos,

SUPREMA

HEPATITE A: QUADRO CLÍNICO

- **Assintomático em 70% dos <6 anos / 30 % das crianças maiores e adultos.**
- **Sintomáticos : i**nício com sintomas gripais, febre , prostração, anorexia, nâuseas, vômitos, diarréia
  - tríade =colúria , hipocolia e icterícia
  - Hepatomegalia/ as vezes esplenomegalia
  - Cura geralmente 30-40 dias
  - 15% quadro prolongado ou sintomas recorrentes (<6meses)

SUPREMA

HEPATITE A

DIAGNÓSTICO

- Dosagem de anti HVA -IgM (positiva a partir de 5-10 dias por 1-2 meses, raro até 6 meses)
- Depois HVA-IgG se torna positiva (por toda vida)

PROFILAXIA : VACINA ANTI HVA

No SUS : dose única aos 15 meses

Calendário SBP e Sbim (12 m-18 m)

Duas doses (100% de soroconversão)

SUPREMA

HEPATITE B

- Alta morbidade e mortalidade
- Infecção responsável pelo aumento no número de transplantes
- Deve ser encarada como infecção a ser erradicada

SUPREMA

HEPATITE B

- Indivíduos com HBsAg + são infectantes mas aqueles com HBeAg são ainda mais infectantes
- OMS: 300 milhões de infectados
- Principalmente : 15 - 39 anos (infecção aguda)
- Apesar da diminuição de casos no mundo com a vacinação : ainda 2 milhões de novos casos por transmissão vertical.

SUPREMA

HEPATITE B

TRANSMISSÃO :

* via percutânea ou mucosa, exposição ao sangue infectado ou fluidos corporais que contenham sangue infectado

Apenas sangue, sêmen e saliva são infecciosos

* Transmissão perinatal ou intrafamiliar: principais fontes de infecção em lactentes e crianças

Grupo de risco : Múltiplos parceiros sexuais e uso de drogas

SUPREMA

Hepatite B

Risco de Hep Crônica

Mãe HbsAg +
HbeAg +

70-90%



Mãe HbsAg +
HbeAg -

10-40%%

Transmissão perinatal

SUPREMA

Transmissão intrafamiliar

- Risco de 14 a 60%

- Contato com lesões dermatológicas, compartilhar escovas de dentes, contato com superficies contaminadas pelo vírus B

SUPREMA

Abordagem na pediatria

- RN e crianças < 6 meses de idade: não dosar HBsAg e VHB–DNA, pois a presença não reflete infecção crônica futura. O resultado pode ser transitório e negativar posteriormente.

- Crianças entre 6 e 12 meses de idade: se expostos, dosar HBsAg e VHB–DNA.

- Crianças > 12 meses e adultos: dosar HBsAg no soro. Repetir em 6 meses após primeiro teste positivo para confirmar infecção crônica.

SUPREMA

HEPATITE B

- Novas infecções mais frequentes em adultos
- Infecções crônicas mais comuns quando a infecção ocorreu na infância

Pessoas com infecção crônica tem maior risco de cirrose e câncer de fígado e mantém o risco de transmissão

SUPREMA

HEPATITE B DIAGNÓSTICO

Hepatite B aguda : HBsAg+ + Anti HBc IgM+

Hepatite B crônica : HBsAg+ + Anti HBc IgG+ (ou total)

As vezes : HBeAg e anti HBe positivos

PCR e quantificação do vírus: apenas para aqueles que vão tratar

SUPREMA

PROFILAXIA : VACINA ANTI HVB

No SUS : disponível ao nascer , depois repetir aos 2,4,6 meses (pentavalente)

Também disponível para adolescentes até 19 anos, para todos os pacientes de risco



Para todas as crianças expostas na GESTAÇÃO: Fazer vacina+ Imunoglobulina (IGHAHB) preferencialmente nas primeiras 24 hs após o parto

SUPREMA

HEPATITE C

- Hepatite não A - não B: principal agente vírus C
- Sofre inúmeras mutações : não confere imunidade a reinfecção por cepa homóloga
- Altas taxas de cronificação (+ 80%)
- Possibilidade de infecções recorrentes

SUPREMA

HEPATITE C

- Lugar de replicação do vírus : fígado mas vírus também tem tropismo pelas células mononucleares do sangue

- Raramente causa infecção aguda
- Pode causar hepatopatia crônica, cirrose e carcinoma hepatocellular

- GRUPOS DE RISCO:Múltiplos parceiros sexuais, uso de drogas injetáveis, trabalhadores da saúde, crianças que nascem de mãe infectada (risco intermediário)

SUPREMA

HEPATITE C

TRANSMISSÃO :

- TRANSMISSÃO VERTICAL : é a via de aquisição mais comum em crianças. Ocorre durante gestação e parto e apresenta maior risco quando o parto é tipo cesariana, quando há exposição prolongada ao sangue materno, mãe com alta viremia (5% de transmissão) ou coinfectada pelo HIV (10%).

- TRANSMISSÃO HORIZONTAL : rara em crianças, aumentando em adolescentes, principalmente usuários de drogas.

– Relações sexuais (pouco frequente, associado a não uso de preservativo), compartilhamento de seringas, agulhas, tatuagens e colocações de *piercings*, materiais odontológicos.

– Contato interpessoal (talvez por lesões de continuidade)

HEPATITE C DIAGNÓSTICO

- **Dosagem de Acs anti-VHC (20-150 dias)**

  significa contato com virus; alguns pacientes tem anti HCV + sem viremia (infecção passada autolimitada)

  Nos RN : pode corresponder a IgG da mãe (atravessa barreira´placentária)

- **PCR na viremia** : RNA VHC detectável 7 a 21 dias após exposição

  significa vírus circulante

Genótipo e quantificação viral quando for tratar o paciente

SUPREMA

Hepatite C

- Na criança <18 meses com IgG + para hepatite C (mãe sabidamente portadora)

  fazer PCR (IgG atravessa barreira placentária) fazer com 3m / repetir 6 a 12 meses após

- Cronicidade em crianças : possibilidade da viremia ceder espontaneamente até 3 a 4 anos após a inoculação : repetir RNA-HVC
- Não há vacinas / medidas de prevenção apenas

SUPREMA

Referências

- MARCONDES, E. et al. **Pediatria básica**. São Paulo: Sarvier; 2003.
- LOPES, F.A; DIOCLÉCIO,C.J; BURNS,D.A.R. **Tratado de Pediatria- Sociedade Brasileira de Pediatria.** São Paulo : Manole 3ª Ed. 2017.

- Aula de hepatites virais

  http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/manual-tecnico-para-o-diagnostico-das-hepatites-virais

SUPREMA